HLA-B*5801 FOR ALLOPURINOL



1. การตรวจคัดกรอง HLA-B*5801

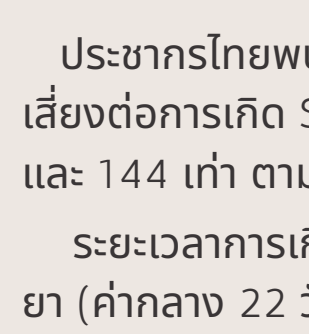
ผู้ที่ควรได้รับการส่งตรวจอัลลีล HLA-B*5801

- ผู้ป่วยทุกรายที่**ไม่เคยได้รับยา allopurinol มาก่อน**
- **เพิ่งเริ่มรับประทานยา allopurinol** อย่างสม่ำเสมอ ติดต่อกันมาไม่เกิน 2 เดือน โดยที่ยังไม่เกิดอาการแพ้ยาใดๆ
- ผู้ป่วยที่เคยได้รับยามาก่อนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และไม่ต่อเนื่อง แต่หยุด หรือ non adherence อาจพิจารณาเป็น new user ได้

ผู้ที่ไม่ควรได้รับการส่งตรวจอัลลีล HLA-B*5801

- มีผลตรวจ HLA-B*5801 อยู่ก่อนแล้ว
- ผู้ป่วยรับประทานหรือเคยรับประทานยา allopurinol สม่ำเสมอ ติดต่อกันมาไม่เกิน 2 เดือน โดยผู้ป่วยยังไม่เกิดอาการแพ้ยา
- ต้องการตรวจ HLA-B5801 เพื่อยืนยันการเป็นสาเหตุแพ้ยา ของ allopurinol เมื่อผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาในขณะที่ใช้ยาหลายชนิดพร้อมกัน

2. กรณีต้องเริ่มการรักษาด้วย allopurinol



START LOW GO SLOW

- **ขนาดเริ่มต้นใช้ยา**

- กรณีไตปกติ: เริ่มต้นใช้ยา 50 mg/day† และค่อยๆปรับ เพิ่มทุก 4-6 สัปดาห์ เพื่อให้ได้ target uric acid level
- กรณีผู้ป่วย CKD หรือ GFR ไม่ดี: เริ่มต้นใช้ยา 1.5*GFR (mg/unit eGFR) วันจันทร์ พุธ ศุกร์† และค่อยๆ ปรับ เพิ่มทุก 4-6 สัปดาห์ เพื่อให้ได้ target uric acid level

การปรับขนาดยาในผู้ป่วย CKD แต่ละ stage

- eGFR 40-59: maximum dose 150 mg/day
- eGFR 20-39: maximum dose 100 mg/day
- eGFR 10-19: 100 mg OD วันเว้นวัน หรือ จันทร์ พุธ ศุกร์
- eGFR < 10: 100 mg OD เว้นทุก 3 วัน

3. การแปลผล

Positive result มี HLA-B*5801 อย่างน้อย 1 อัลลีล	ผู้ป่วยมีความ**เสี่ยงสูง**ต่อการเกิดแพ้ยาแบบ SJS/TEN, DRESS และ MPE
Negative result ตรวจไม่พบอัลลีล HLA-B*5801	ผู้ป่วยมีความ**เสี่ยงปกติ** (ไม่แตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่) ต่อการเกิดแพ้ยาแบบ SJS/TEN, DRESS และ MPE

4.การให้คำแนะนำปรึกษาโดยเภสัชกร



กรณี Genotyping Positive:

- อธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่าผู้ป่วยมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงถึงการ**มีความเสี่ยงสูง**ต่อการแพ้ยา allopurinol ทั้งแบบรุนแรงและไม่รุนแรงที่พบได้บ่อย
- หากแพทย์ตัดสินใจใช้ยา allopurinol ต่อไป ควรแนะนำให้ผู้ป่วยสังเกตอาการแพ้ยา โดยเฉพาะในช่วง 2 เดือนแรกหลังจากเริ่มใช้ยา
- ผู้ป่วยควรพกบัตรเตือนหรือบัตรแพ้ยา (กรณีที่มีอาการแพ้ยาเกิดขึ้นแล้ว) ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลหรือร้านยาต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดแพ้ยาซ้ำในอนาคต

5. ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงและหลักฐานเชิงประจักษ์



- **Risk factors**: ข้อมูลงานวิจัยหลายฉบับพบว่าปัจจัยทางคลินิก เช่น

-เพศหญิง, อายุ >60 ปี, มีโรค CKD หรือ CVD, asymptomatic hyperuricemia, ใช้ยากลุ่ม thaizides, starting allopurinol dose >100 mg/day และ genetic variation (HLA-B*5801)

ประชากรไทยพบ HLA-B*58:01 ร้อยละ 16.337 และผู้ที่มีอัลลีล HLA-B*58:01 จะมีความเสี่ยงต่อการเกิด SJS/TEN, DRESS และ MPE ได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีอัลลีลดังกล่าวถึง 579, 430 และ 144 เท่า ตามลำดับ

ระยะเวลาการเกิด SCARs จากยา allopurinol ประชากรไทยมีรายงาน 7-42 วัน นับตั้งแต่เริ่มยา (ค่ากลาง 22 วัน)

หมายเหตุ: † ข้อมูลจากการปฏิบัติของแพทย์ผู้เชียวชาญ
ACR guideline แนะนำเริ่ม Allopurinol ไม่เกิน 100 mg/day กรณีผู้ป่วย CKD เริ่มต้นใช้ยา 1.5*GFR (mg/unit eGFR/day)

เอกสารอ้างอิง

1.รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ, รศ.ภญ.ธิดา นิสานนท์. แนวทางปฏิบัติทางเภสัชกรรมคลินิกสำหรับการตรวจลักษณะพันธุกรรม HLA-B*5801 เพื่อประกอบการใช้ยา Allopurinol ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564. โครงการวิจัย เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ACR-EULAR gout classification criteria calculator[Internet]. New Zealand: The university of Auckland; 2015 [cited 2022 Oct 16]. Available from: http://goutclassificationcalculator.auckland.ac.nz/

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ข้อมูล ณ วันที 16 ตุลาคม 2566